

11 - Module II

Bonjour, le plan que je vous propose pour ce module s'articule autour de trois axes. Le premier est la santé et la maladie, à partir d'une approche socio-historique de la maladie, donc autour de la naissance de la maladie, sur la construction sociale, et on verra l'importance de cette approche historique. Elle s'articule aussi autour du besoin du regard scientifique sur la santé, de sa naissance, de comment il s'est imposé, surtout du point de vue des sciences sociales.

Et puis, dernier élément, c'est celui des domaines de la sociologie de la santé. Donc ça, c'est l'élément fondamental qui va nous servir de ligne directrice dans tout ce qu'on va voir par la suite. Et puis le deuxième axe, c'est celui de l'évolution de la médecine et de la médicalisation, évolution qui pose des questions, qui pose des débats actuellement.

Et enfin, l'évolution de l'institution hospitalière et des fonctions sociales. La problématique de la construction sociale de la santé et de la maladie est très importante, parce qu'elle pose beaucoup de questions. D'abord, comment est née l'approche biomédicale, quel est le contexte historique de son émergence, et puis la possibilité aussi de remise en question de ce modèle vers de nouveaux modèles, qu'on va discuter par la suite.

Et puis surtout, nous allons esquisser les critiques sociologiques que l'on portait sur la profession médicale, et qui ont remis en question les prétentions, mais aussi la crédibilité de la biomédecine, en tant que moyen de diagnostiquer et de guérir les problèmes de santé, et des critiques qui soutiennent que cette approche a été exagérée, parfois en connue des limites. Premièrement, on peut dire que le modèle biomédical éclaire l'approche des connaissances sur la pratique des soins de santé, et que la maladie a été considérée longtemps comme une déviation, c'est-à-dire par rapport à la norme, par rapport à ce qui est normal, une déviation légitime, du moment que le patient n'en est pas responsable, c'est quelque chose qu'il subit. C'est ainsi qu'on considère la maladie, on verra, la vision est beaucoup évoluée par rapport à cet élément-là.

Deuxième chose, c'est que la maladie peut avoir une signification différente selon la position sociale de l'individu qui en souffre, donc il y a lieu de regarder de près les différentes significations, au moins selon cet élément dont on vient de parler. Troisième élément, c'est que le professionnel de la santé doit lui-même être conscient des significations autres que celles relevant uniquement de la biomédecine, des significations symboliques, sociales de la maladie, et de la santé, et qu'il y a maintenant presque, au niveau mondial, un consensus sur le fait que la maladie revêt d'autres aspects qu'on a passés sous silence, et que même si on veut réussir l'acte, disons, de l'opération de guérison, ces éléments-là doivent être pris en compte. Dernier élément, c'est que consiste à considérer qu'un comportement ou une expérience particulière de la maladie appelle, interpelle ou relève aussi de valeurs culturelles, qui sont liées à chaque société, à sa culture, en normes sociales, ce que chaque société ou à chaque époque historique fixe comme normes de ce qui est normal, de ce qui est pathologique, de ce qui relève de la maladie, de ce qui relève de la santé.

Et un troisième élément, c'est celui des règles d'interprétation partagées, ces règles d'interprétation sont partagées, quand on dit partagées, partagées d'abord entre la communauté scientifique, entre les praticiens qui exercent la profession, mais aussi entre d'autres catégories qui étaient jusque-là, en quelque sorte, cachées, ou au moins tacites, mais que maintenant émergent comme des acteurs extrêmement importants. Donc, on peut parler des maîtres de fond, on peut parler des administrateurs, on peut parler des politiques, on peut parler des associations, des associations des malades, en l'occurrence, etc. Donc, on a beaucoup de catégories d'acteurs sociaux qui participent à la définition de la santé, de la maladie, des enjeux par rapport à la santé.

Donc, ce sont ces règles d'interprétation, qui gagnent à être partagées entre ces différents acteurs, pour donner lieu à des débats, pour donner lieu à une compréhension commune, au moins que ça donne des bases de compréhension, pour que la discussion par rapport à la santé et à la maladie puisse aboutir à des modèles adaptés aux besoins de la société à un temps donné. Alors, le dernier élément, c'est que le même phénomène biomédical peut signifier différentes choses selon les contextes. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que selon les époques historiques, selon aussi les différents contextes, on verra que les sens peuvent changer.

Alors, notre objectif, en parlant du besoin d'une sociologie de la santé, c'est d'expliquer comment la pensée sociologique peut être utilisée pour remettre en question l'approche biomédicale de la santé et de la maladie. Mais aussi comprendre comment les approches sociologiques identifient la santé et la maladie comme des constructions sociales. Il est vrai que le modèle biomédical est si puissant et dominant dans les systèmes de santé modernes, en l'occurrence dans les pays occidentaux, qu'il peut être difficile de croire qu'il existe d'autres gammes d'alternatives crédibles.

Donc ça, ce sont quelques questions qui s'imposent, mais qu'on peut décliner en sous-questions. D'abord, l'évolution de la relation de la santé et de la société selon l'histoire, en quoi ça a changé, en quoi elle a connu des modifications, en quoi elle a changé le regard même sur la maladie, sur le patient. Et ce sont des modifications que l'on vit actuellement.

En quoi les stratégies de santé aussi changent selon des paradigmes autour de la guérison, du soin, de la prévention de la maladie. Et puis aussi, quelles sont les relations de pouvoir entre les différents acteurs. Cela signifie qu'il faut identifier ces acteurs qui ne se limitent pas uniquement aux médecins et aux patients au sein de l'hôpital, mais qui concernent aussi le personnel soignant, les infirmiers, les administrateurs, etc.

Et puis, en dehors de l'institution hospitalière aussi, les autres acteurs qui ont des relations de près de loin avec la santé. On ne peut pas parler des maîtres de foi, sur le plan financier, des politiques, sur le plan de la prise de décision politique et de l'élaboration des politiques publiques de santé, mais aussi d'autres catégories, telles que les associations, ça peut être les associations de malades, etc., ou les ordres, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, etc. Donc, ça

peut aller au-delà même d'autres acteurs au niveau international.

On peut aussi se poser des questions sur les relations professionnelles et sur leur type. Est-ce qu'il s'agit de relations de collaboration avec l'État, garant des droits, garant des intérêts publics, ou ce sont des relations de conflit ? Ça, on peut l'observer à travers la presse, à travers les mouvements sociaux, que ce soit des protestations, ça peut être aussi des bras de fer avec l'État sur des questions spécifiques liées à la santé. Ça peut prendre aussi des formes carrément de rupture, parfois d'admission d'un certain nombre de professionnels de la santé, etc.

On peut se poser aussi la question sur quelle est la place des nouvelles spécialités médicales, parfois même des nouvelles médecines dites parallèles ou alternatives, etc. Et on peut remarquer, bien sûr, que chaque pays, chaque contexte, traite la question à sa façon. Dans certains pays, certaines professions ont été reconnues qui, il y a dix ans, ont été combattues, alors que là, elles sont intégrées comme étant crédibles et justifiées, etc.

Comment ça se passe ? Comment se fait cette reconnaissance ? Et comment cet élargissement à ces nouvelles spécialités modifie en quelque sorte les positions des uns des autres et modifie la notion de la santé, la notion de la maladie ? La relation entre les professionnels de la santé eux-mêmes, quelle est la relation entre les médecins et les infirmiers d'un côté et l'administration dans l'autre, ça fait l'objet de beaucoup de questions qui ont été traitées par la sociologie de la santé. Et puis, quel équilibre entre les professionnels de la santé d'un côté, entre l'État, qui joue le rôle de médiateur, et le patient, le patient en tant qu'individu, mais aussi le patient organisé. Quand on dit le patient organisé, dans un certain nombre de cas, on assiste à l'émergence d'associations de patients, d'associations de patients, par exemple de VIH, ou des diabétiques, etc.

Et que dans un certain nombre de pays, ces associés jouent un rôle extrêmement important, d'abord de plaider, de lobbying, et qui peuvent parfois changer les positions des autres acteurs, et peuvent peser par leur poids dans le débat, et peuvent changer la réglementation, etc. Donc ça, c'est extrêmement important à souligner. Et puis, de façon beaucoup plus globale, qu'il y ait la relation entre une médecine crédible, une médecine qui est reconnue, et puis des médecines alternatives, comme on le disait tout à l'heure, qui élargissent un petit peu le champ de ce qui est la santé, de ce qui est la maladie, et parfois donnent de nouveaux sens à ce qu'est la santé et la maladie.

En l'occurrence, on peut prendre par exemple les médecines dites médecines orientales, qui considèrent, en plus du corps humain, considèrent l'aspect spirituel, et qui parfois fait partie de la pratique, fait partie de la pratique médicale, fait partie des objectifs et des dispositifs de guérison, de soins et de prévention. Alors la sociologie de la santé peut être définie de plusieurs manières, mais globalement on trouve près les mêmes éléments fondamentaux. La première, c'est celle que je vous propose, celle de l'association américaine de sociologie, qui nous dit que la sociologie de la santé et de la médecine est une spécialisation de la sociologie, et qui applique

les méthodes de la sociologie, donc les concepts et l'idéologie de la sociologie, au domaine et au phénomène lié à la santé et à la maladie.

Une deuxième définition, qui est proche de la première, il dit que la sociologie de la santé est une branche des connaissances encore en construction, donc c'est une sociologie en cours de construction, et on le verra, c'est une branche assez récente, qui essaye de focaliser son travail sur le domaine de la santé, sur les phénomènes de la santé, et à découvrir et à mettre en place des protocoles de recherche, et à élaborer des théories qui sont relatives à ce domaine très spécifique. Alors la sociologie de la santé, comme branche de la sociologie, partage avec les autres sociologies des concepts, des théories, des démarches. Le schéma suivant montre un petit peu les différentes thématiques de la sociologie, elles sont plusieurs, notamment la question du pouvoir et de l'État, de la globalisation, le genre, l'éducation, la religion, la culture, l'identité, les familles, la sociologie du crime ou de la déviance, etc.

Il y a plusieurs spécialités, et uniquement c'est un échantillon de spécialités, mais c'est uniquement à titre indicatif, pour montrer les spécialités de la sociologie, qui partagent avec la sociologie de la santé un certain nombre de questions, et qui peuvent l'alimenter. Alors la sociologie de la santé et du bien-être, elle traite d'un certain nombre de questions, c'est comment on commence de la gauche à la droite, par la notion de la maladie mentale, qu'est-ce que c'est que la maladie mentale, quelles sont les idées et les représentations du corps, de relations entre le patient et le médecin, c'est un troisième thème. Troisième thème c'est la connaissance médicale, qu'est-ce que c'est que la connaissance médicale, comment on la produit, et puis sa relation avec le pouvoir.

Un autre thème c'est celui de la déviance, et le rôle du malade, comment on considère ce qui est pathologique, ce qui est normal, comment le malade doit se comporter, etc. Et puis le thème suivant, c'est celui des déterminants sociaux de la santé, c'est un thème qui est très important en sociologie de la santé, on verra par la suite. Et puis l'expérience de la maladie, ce qu'on appelle les cadres de l'expérience de la maladie, ça regroupe un tas d'études récentes, qui focalisent sur l'expérience chronique, comme étant une expérience vécue sur le long terme, et que la maladie n'est pas uniquement un état déviant qu'il faut corriger, mais que c'est un état qui se situe dans la durée, et qui modifie les relations du malade avec son entourage, avec son alimentation, avec son comportement quotidien, qui doit prendre un certain nombre de précautions, de comportements qui ont un certain nombre d'importance par rapport à son entourage, par rapport à lui, qui peut changer, modifier ses relations aux autres, etc.

Donc ça c'est très important comme thème, et qui émerge, comme on le verra, pour lequel on consacre un module à part. Et puis la question du genre et de l'ethnicité dans la santé, on le verra surtout dans certains autres pays, ce sont des questions qui ont beaucoup émergé, en Angleterre, aux Etats-Unis, un peu moins en France, pour la raison simple que ce sont des pays qui ont été constitués par des vagues de migrants, et qui sur le territoire cohabitent des populations de différents horizons, et de différentes origines, et donc la question se pose sur la

capacité du système médical de répondre aux besoins de tous ces groupes, et de voir comment ces groupes eux-mêmes se représentent la maladie, comment ils accèdent ou n'accèdent pas aux soins. Donc c'est une question d'accessibilité, une question aussi de droit, une question de reconnaissance de droit.

Et la même chose aussi pour le genre, dans quelle mesure l'analyse du genre, selon le genre, prend en compte la relation de l'homme et de la femme, en différenciant un petit peu les relations qu'ils entretiennent d'une part avec la santé, avec l'institution hospitalière, avec les lois, et comment, en contrepartie, ces institutions aussi gèrent cette question du genre. Est-ce qu'il y a une approche différenciée selon le genre ? Est-ce qu'on prend en compte des spécificités selon que les malades sont des hommes ou des femmes, etc. Est-ce qu'il y a une complémentarité ? Est-ce que c'est un système qui tient compte de ce qu'on appelle les indicateurs qui sont liés au genre, aux indicateurs sexo-spécifiques, etc.

L'autre thème, c'est celui du comportement du malade, du comportement de la maladie, si vous voulez. Donc, la sociologie s'est intéressée, et on le verra, c'est un domaine qu'elle partage avec la psychosociologie de la santé, auquel on va aussi consacrer un module pour justement discuter de cet aspect des modèles de comportement. Les chercheurs en psychosociologie, notamment, essayaient de comprendre, en utilisant un certain nombre de modèles, de comprendre quelles sont les différentes possibilités, qui sont prévisibles face à la maladie, face à un certain nombre de facteurs externes.

Le thème du pouvoir et de la professionnalisation, et du professionnalisme aussi dans les métiers du soin ou du cœur, c'est important parce que c'est un domaine qui émerge, et tout simplement parce que la notion du soin dépasse maintenant uniquement la relation entre le médecin et l'hôpital. Si on prend par exemple le cas des malades, surtout ceux qui sont en train d'une maladie chronique, on parle aussi de la personne qui accompagne le malade, qui peut être un proche parent, qui peut être quelqu'un de son voisinage. Cette personne joue aussi un rôle important.

Parfois, cette personne est aussi affectée par la maladie. Est-ce qu'on peut parler de professionnalisation, des métiers du soin, par qui, comment, etc. Ou alors on limite le regard uniquement à ceux qui sont reconnus jusqu'à là, et qui ont obtenu cette reconnaissance par des diplômes, via un cursus scolaire, etc.

Et puis, finalement, ça, on y arrive. C'est l'expérience de la maladie chronique, comme on l'a dit plus haut, qui mérite qu'on s'y arrête davantage, parce que c'est un domaine qui a posé beaucoup de questions, surtout dans le domaine de la psychosociologie de la maladie, et qui a amené à se poser des questions par rapport à ce qu'est la maladie, et à l'expérience de la maladie en tant que telle. Le concept de maladie revêt plusieurs dimensions.

D'abord, il y a une dimension culturelle de la maladie, comment on reçoit la maladie, comment on

reçoit les symptômes, comment on peut savoir qu'on est malade ou qu'on n'est pas, donc à partir d'un certain nombre d'éléments, qui sont d'ordre culturel. On va revenir sur cet aspect-là par la suite, pour voir un peu l'importance de cet aspect-là. Et puis le deuxième élément, c'est celui de Cygnès.

C'est dans la littérature anglo-saxonne, qui renvoie à des dimensions sociales. Quel intérêt on reconnaît à la maladie, et l'importance de la gravité de la maladie, on lui reconnaît au plan économique, au plan social, etc. Quels moyens on mobilise pour la maladie.

Donc c'est une dimension qui mobilise un peu le groupe social, par rapport à cette question-là. Et puis finalement, c'est le concept de disease. Un disease, c'est un concept qui revoit à la dimension biologique.

Dans la définition de ce qui est anomalie, de ce qui ne l'est pas, de cette déficience ou déficit, est-ce qu'il y a un manque donné par rapport à une situation normale. Donc au moins, ces trois dimensions ont été souvent étudiées et constituent différents, si vous voulez, différents angles de la maladie. Et parfois, on s'intéresse à une dimension sans prendre en compte les deux autres.

Or, les travaux de la sociologie et de la santé, les sciences sociales qui se sont intéressées à ces aspects, mettent en lumière au moins la différence entre ces trois dimensions dans toute approche de la maladie. Alors, on vient de le voir, il est de plus en plus admis que la signification de la maladie est déterminée par plusieurs éléments, dans le contexte culturel dans lequel elle se produit. Et que les définitions de la maladie reposent sur des définitions sociales de la normalité.

Elles sont donc beaucoup plus problématiques pour les médecins de les déterminer ou de se prononcer dessus, c'est-à-dire sur la maladie, sans prendre en compte ces autres éléments. Alors, bien sûr, les définitions populaires de la maladie coïncident parfois avec les définitions médicales, ça c'est sûr. De ce qu'on appelle la normalité, ce qui est normal du point de vue biologique, mais pas souvent.

Et c'est un point très important à noter, c'est que les maladies sont culturellement spécifiques et généralement l'utilisation par les individus des définitions culturellement spécifiques de la maladie les amène à décider et à demander ou non de l'aide. Peut-être même de consulter ou non les agents de santé. D'où l'intérêt de comprendre quels sont ces éléments-là qui sont parfois à la base de ces décisions.

Vous voyez que même l'acte de soin lui-même est parfois décidé et défini par ces éléments-là qui peuvent être des éléments extérieurs. La sociologie nous dit qu'il faut tenir en compte un certain nombre d'éléments que nous allons esquisser tout de suite, mais uniquement avec quelques questions, pas toutes. La première c'est comment est organisé le domaine de la santé, comment fonctionne la profession médicale par exemple, et puis après quels sont les problèmes d'accès de la population aux services médicaux, et aussi quel est le rôle de la médecine en tant qu'une institution et quelles relations elle entretient avec les autres institutions quand on dit les

institutions politiques, avec l'éducation, avec l'institution religieuse, etc.

Ce sont des institutions nombreuses et on le verra, qui peuvent être aussi des acteurs dans cette relation que peut avoir la médecine avec les autres institutions. Et puis quel rôle jouent les variables sociales, ça on l'avait dit dans l'Inès, c'est-à-dire que la définition de ce qui est un symptôme de la maladie dans l'éthiologie de la maladie, quel rôle joue cette dimension sociale dans la définition des symptômes de la maladie, ou qui les exagèrent, qui les définissent autrement, qui les interprètent d'une façon assez particulière, qui reconnaissent dans ces symptômes autre chose que le regard biomédical pur, le pouvoir, etc. Autre question c'est comment les maladies sont réparties dans différents groupes de la population, et qu'est-ce qui explique cette répartition, on en a parlé avant sur la répartition des maladies entre les différents groupes ethniques, en Angleterre ou aux Etats-Unis, qui fait l'objet de beaucoup de travaux.

La répartition de la maladie entre les différents groupes d'âge, entre les jeunes, les vieux, les moins vieux, etc. Entre les hommes, les femmes, etc. Entre des groupes de population aussi, entre des groupes professionnels.

Pourquoi certaines maladies se déclenchent dans certaines populations, dans certains métiers, etc. Et puis, une autre question, ce que les gens font pour maintenir, améliorer, ou récupérer la santé, ou pour faire face à un handicap. Toutes les stratégies individuelles, mais qui impliquent aussi des stratégies de groupe, de prise en charge de la maladie.

Est-ce que les individus décident immédiatement, et ça, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les modèles de comportement face à la maladie, est-ce que c'est une décision individuelle, ou est-ce que le malade prend en considération la vie de ses proches, est-ce qu'il fait référence à d'autres ressources pour constituer une espèce de réservoir d'idées avant de prendre la décision. Ça peut aller de ses voisins, de ses amis, de son réseau de proches, de l'association des malades à laquelle il appartient, de réseaux d'internet, etc. Donc voilà, ce sont des éléments qui peuvent jouer un rôle extrêmement important, et dont il faut tenir compte, il faut les comprendre d'un point de vue sociologique.

Et puis, une question qui consiste à étudier les attitudes et les croyances et les représentations des patients, des médecins et des professionnels de la santé, de la santé de l'homme. Ça veut dire que tout un chacun élabore des représentations autour de la maladie. Ce sont des représentations qui sont élaborées, ce sont des représentations parfois collectives, qui sont partagées avec d'autres personnes, avec d'autres groupes sociaux, ou qui sont parfois collectives, qui sont très courantes dans une société donnée.

Mais parfois, il existe des représentations individuelles, l'individu lui-même se représente d'une façon ou d'une autre la maladie, et ces représentations dictent en quelque sorte son attitude par rapport à telle maladie ou à tel ou tel soin. Ça peut être une approche compréhensive, une attitude compréhensive, une attitude, disons, très réservée, ou une attitude parfois

sympathisante, ou une attitude indifférente. Donc voilà, on a différentes attitudes par rapport à la maladie, ou par rapport au soin, ou par rapport à telle médecine, ou par rapport à telle... Donc on a une diversité, en fait, d'attitudes.

Et puis, les pratiques aussi sont différentes. Les choix des individus par rapport à la question de la santé sont aussi différents. Donc là, ce sont quelques questions, pas les seules, qui sont données comme exemples de quelles questions pose la sociologie de la santé.

Vous voyez que ce sont des questions fondamentales parce qu'elles traitent de la notion de la maladie, de l'organisation par rapport au soin, des institutions, du pouvoir, etc., d'un certain nombre d'éléments qui peuvent intéresser aussi bien l'étudiant en médecine qui construit son parcours et son projet par rapport à son métier que par rapport au praticien, déjà, qui est dans l'exercice de son métier. On peut dire que les idées sur la santé et sur les pratiques de soins de santé ont une très longue histoire. La façon dont les gens ont pensé à la santé et ont utilisé ces idées pour essayer d'influencer le cycle de vie, le processus pathologique, parfois présenté comme un processus linéaire, c'est-à-dire d'amélioration continue et de progrès, depuis des débuts qui étaient simples de la médecine, on va voir que c'était des débuts où la médecine ne connaissait pas les progrès actuels, vers des horizons très sophistiqués.

Maintenant, on parle de médecine très sophistiquée, on le verra par la suite, médecine très scientifique, comme on le sait aujourd'hui. Comme on le sait, bien que la médecine moderne s'inspire des idées antérieures sur la santé, il est important de clarifier en quoi l'approche scientifique de la médecine et son émergence dans un contexte social et historique sont liées. C'est comprendre l'évolution de la médecine.

Il ne s'agit pas de faire uniquement une lecture historique pour nous de la médecine, de voir une espèce de fresque historique, de voir les grandes dates, mais de regarder en quoi chaque étape est influencée par l'étape précédente et qu'il y a chaque étape d'évolution de la médecine qui s'est faite en réaction, en intégrant, en dépassant l'étape précédente. Et l'étape future sera aussi une évolution par rapport à l'étape actuelle. C'est un mouvement continu d'évolution de la médecine.

Si on est d'accord sur cet élément-là, on pourra déjà dire qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont eu lieu dans le domaine social et politique, comme on l'a vu dans notre premier module sur la sociologie, sur l'évolution de la société au XVIIIe, XIXe siècle. Mais ces changements ont impacté aussi le domaine de la médecine. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect-là.

Tout à fait au début de la médecine, la religion fournissait le système dominant de connaissance, c'est l'étape première de connaissance. Elle fournissait aussi la manière de voir et d'expliquer les phénomènes, qui étaient souvent des phénomènes qui dépassaient la société, sur lesquels on n'avait pas prise. Parfois, on donnait des explications en termes de volonté de Dieu,

d'intervention divine, etc.

Ça, c'est à peu près jusqu'au XVII^e siècle, on va dire au XVIII^e siècle. Et puis, rapidement, la pensée rationnelle, c'est-à-dire de penser les maladies, penser la science et les questions de santé de façon rationnelle, se sont imposées surtout au XVIII^e et au XIX^e siècle, parce que la science s'est développée. Entre autres, par des médecins.

Elle est devenue, comme pensée rationnelle, la source de vérité et qui a pris le relais par rapport à toutes les explications qu'on donnait avant de la maladie et qu'on donnait du point de vue religieux. Et la troisième étape, si vous voulez, c'est l'étape d'une nouvelle façon. C'est-à-dire surtout au XIX^e siècle, on a vu émerger une médecine avec une nouvelle façon scientifique qui consiste à utiliser, à penser et à traiter d'abord la question de la santé, mais pendant laquelle les médecins se sont affirmés.

C'est une période extrêmement importante où les médecins ont émergé comme une catégorie qui utilise des méthodes scientifiques pour identifier et traiter les problèmes de la santé. Ils ont fait justement assurer ce développement rapide des techniques et des procédures en appliquant une pensée scientifique clairement scientifique et qui est rompue avec les idées d'avant. Ils ont appliqué ces idées sur les soins du corps de l'individu malade.

Du coup, la science est devenue un système dominant de connaissances pour les médecins et qui va s'imposer au XX^e siècle. On a vu émerger aussi lors de cette évolution différents types de meetings reconnus sur le plan historique par la médecine d'État. La médecine d'État qui est née en Allemagne au début du XVIII^e siècle où c'est l'État qui prend en charge la question de la maladie et qui tente de normaliser les professionnels de la santé.

Ce sont les premiers débuts de la réglementation de la santé. Avant la santé ça relevait des églises ça relevait d'un autre regard, d'autres catégories. Là en l'occurrence la médecine est devenue une affaire d'État.

Une autre médecine qui va émerger et qui va impacter la médecine qu'on connaît actuellement c'est la médecine urbaine. Cette médecine est née en France et elle a essayé de répondre à des questions d'urbanisation croissante et avec le développement d'un certain nombre d'éléments liant l'environnement, la cohabitation, la circulation d'éléments tels que l'eau, l'air, etc. C'est plutôt une médecine qui a focalisé moins sur les malades que sur les conditions dans lesquelles ils vivent.

C'est très important de le souligner. En Angleterre, notre modèle est né et celui qui consiste à contrôler surtout la vaccination, contrôler la circulation de la maladie surtout dans des milieux nécessitant des milieux de personnes démunies, des milieux de classes pauvres et ce sont nés les premiers services de santé, de proximité on peut rajouter le terme de proximité, c'est-à-dire par rapport à ces personnes avant que la maladie ne se propage pour être au plus près de ces personnes qui sont le plus en besoin. D'où est née les premières réflexions sur la question des

épidémies et des maladies qui peuvent intéresser tout un groupe de personnes et qui peuvent connaître une évolution extrêmement rapide.

Donc voilà comment à un moment donné le raisonnement autour de la médecine, autour de la santé va prendre des dimensions différentes par rapport à des contextes différents sa réglementation et sa gestion par l'Etat c'est ce qu'on appelle la médecine de l'Etat en Allemagne développement de cette nécessité surtout en France qui a connu un mouvement de déorganisation rapide alors que l'Angleterre avait connu ce mouvement beaucoup plus avant la France avec d'autres relents et avec un souci de contrôle social du corps donc ça c'est cette période historique qui va donner un petit peu les différentes dimensions et qui va en quelque sorte poser des questions qui vont être débattues même jusqu'à l'heure actuelle Pour traiter les fonctions sociales de l'hôpital et leur évolution historique les historiens ont essayé de faire l'histoire des hôpitaux donc l'histoire remonte à ceci on a des descriptions des premiers temples dédiés aux dieux guérisseurs dès la Grèce antique puis on dispose aussi de preuves de l'existence de temples notamment des hôpitaux brahmaniques au Sri Lanka dès 431 avant Jésus-Christ et puis l'histoire nous enseigne que le roi Ashoka a créé une chaîne d'hôpitaux dans l'Hindustan environ 230 ans, à peu près deux siècles et un quart de siècle avant Jésus-Christ et puis avec les romains ont été créés des hôpitaux pour le traitement de leurs soldats malades et blessés et qui avaient des fonctions très spécifiques réservées en gros à l'élite donc ces infirmeries pour les soldats et des infirmeries aussi pour les esclaves parce qu'ils avaient une fonction sociale précise et puis on peut dire que le concept de l'hôpital moderne ayant été converti au christianisme a aboli tous les hôpitaux qui sont hérités des anciennes pratiques païennes et depuis la notion de la charité a été associée à celle de l'hôpital alors sous d'autres latitudes et dans d'autres civilisations on a vu émerger le premier système hospitalier selon les historiens, notamment sur la Perse antique avec l'académie de Gondi-Chapour et qui va servir de modèle dans tout le monde arabo-musulman, de Bémaristan qui va se développer sous Harun Rashid mais on trouve aussi des modèles de Bémaristan qui vont jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire récente c'est-à-dire juste avant le protectorat au Maroc notamment dans le cas de Bémaristan donc comme on le disait, le concept moderne de l'hôpital a été lié depuis le début au christianisme qui avait aboli les anciens modèles des hôpitaux dits à d'autres divinités et la tradition chrétienne met l'action sur la relation étroite de la victime avec les membres de la communauté sur lesquelles repose l'obligation de soins la maladie est devenue ainsi un problème pour l'église chrétienne qui comprend en quelque sorte aussi bien la question religieuse celle de prendre soin de l'âme de prendre soin des pauvres, des personnes âgées des malades, mais aussi des personnes souffrant de la lèpre et l'hôpital ressemblait à une unité plutôt d'isolement de ces personnes suivant cet exemple, des hôpitaux ont été construits dans la partie orientale de l'empire romain plusieurs centres qui vont accueillir les personnes nécessiteuses et c'est à partir à peu près, comme on le verra à partir du XIe siècle que on verra l'apparition de nouveau des ordres hospitaliers ce sont des ordres créés par des groupes depuis eux qui vont, à l'instar des monastères qui les ont précédés qui faisaient des moines en quelque sorte, en même

temps ceux qui vont accueillir les personnes en déplacement pèlerinage qui vont accueillir les personnes en besoin mais aussi qui vont accueillir les personnes souffrant des épidémies ou des maladies donc il y avait cette apparition de ces ordres hospitaliers qui vont se dédier en quelque sorte à ce travail, donc ça, ça constitue en quelque sorte une espèce de revirement vers cette tâche avec l'apparition d'infirmes monastiques qui vont jouer un rôle extrêmement important dans la diffusion d'une espèce de nouvelle relation à la maladie qui comprend aussi comme on le disait, le bien-être de l'âme du patient qui était davantage consacré à la guérison des infections corporelles, mais aussi au salut de l'âme et la manière dont les moines s'occupaient de leurs propres malades devint en quelque sorte un modèle aussi pour les laïcs les monastères avaient des endroits spécifiques où leurs malades étaient emmenés pour le traitement et avaient aussi une pharmacie et souvent un jardin aussi avec des plantes médicinales qui servaient aussi à faire des décoctions, à faire des infusions donc en plus de prendre soin des malades des moines malades, les monastères ont ouvert aussi leurs portes aux pèlerins et aux voyageurs et ont joué un rôle important comme institution qui va accueillir aussi les indigents du pays, les orphelins, les veufs parfois les mutilés les estropiés et tous ceux qui sont malades donc il n'y avait pas une distinction entre les catégories qui vont bénéficier des soins donc comme on le voit, c'était une fonction essentiellement sociale qui remplissait justement ces centres et qui vont jouer ce rôle de protection de la société contre la contagion qui vont jouer un rôle aussi dans la diffusion aussi du premier savoir sur le traitement de la maladie et ce n'est que vers vers le 14^e siècle essentiellement que les hôtels d'yeux qui étaient dédiés à cette tâche vont connaître une certaine dégradation et vont être abandonnés au profit des premiers hôpitaux sous Louis XIV et ces hôpitaux vont assurer les soins et protéger la société contre les différentes contagions. Donc on est passé du modèle où des hôtels d'yeux étaient rattachés à l'église et au monastère à un nouveau système qui est plus géré par l'État géré par le pouvoir central et qui est géré en quelque sorte par le pouvoir laïque qui n'est pas très directement rattaché à l'église. Chemin faisant ont été instaurées les premières formations hospitalo-cliniques en Allemagne en Autriche, en Italie, en Écosse et en France et en dénombre justement plusieurs hôpitaux qui quadrillaient un petit peu tout le territoire et qui offraient des services au niveau de tout le pays et avec justement un réseau à travers lequel les médecins de l'époque ceux qui étaient en charge des soins pouvaient échanger pouvaient capitaliser sur leur savoir former, défendre leurs intérêts et émerger comme de nouveaux acteurs dans le domaine de la santé et des soins domaine qui était réservé auparavant au domaine ecclésiastique qui est un domaine qui est relié à l'église.

Alors comme on vient de le voir les institutions hospitalières ont connu des fonctions qui ont évolué avec les sociétés avec le contexte dans lequel elles ont été créées et remplissaient justement un rôle plusieurs rôles, mais aucunement un rôle médical, une fonction médicale. Et avec Michel Foucault on peut remarquer que le développement de la vie urbaine surtout depuis le Moyen-Âge a imposé la création de lieux d'internement de tous les déviants par rapport à la société, que ce soit des fous des prostituées, des malades qu'on regroupait tous dans l'hôpital général. D'autres auteurs distinguent trois étapes de l'évolution des institutions hospitalières.

Les établissements qui n'avaient aucune spécialité comme on l'a vu, et qui avaient un rôle d'assistance sous toutes ses formes, assistance sociale rattachée aux paroisses, qui pouvaient accueillir les invalides, les enfants abandonnés, les malades etc. Et puis les hôtels-lieux constituent l'institution qui était réservée exclusivement aux malades. Mais les hôpitaux généraux l'hôpital général accueillait tous ceux qui étaient refoulés des hôtels-lieux.

Et ces personnes étaient souvent des marginaux qui étaient exclus de la société pour un motif donné. Et l'hôpital dans ce cas, l'hôpital général, avait une fonction régulatrice de l'ordre social. Plutôt qu'une fonction indicale.

Alors toujours en se référant à Foucault, on peut dire avec lui que l'hôpital n'avait pas les fonctions indicales qu'on lui connaît actuellement, mais qu'il va s'imposer surtout entre 1780 et 1790 comme un lieu de cure et aussi un lieu de formation médicale. La clinique qui va s'imposer, comme on l'a vu, on le verra, c'est un nouveau regard qui va s'imposer avec la clinique. Et partant, l'organisation même de l'hôpital comme un lieu non seulement d'exercice mais aussi un lieu de formation et de transmission d'un savoir qui est systématisé et qui va être transféré dans ce forme de cours, ce forme de pratique, etc.

Donc, l'introduction de la discipline de l'espace hospitalier qui va aussi permettre une gestion très rigoureuse de cet espace-là. Et également, l'observation du malade qui va disposer d'un lit, qui va être suivi, qui va être observé, va être quelque chose de nouveau. Avant, ça ne se faisait pas en accueillie, c'était juste une assistance à ceux qui avaient des problèmes qui peuvent être, bien entendu, des malades mais aussi d'autres catégories comme on l'a vu.

Là, en l'occurrence, l'émergence de l'hôpital comme institution dédiée aux malades et qui va être soumise à l'observation, qui va être justement, qui va faire l'objet de tout un travail qui permettra de noter l'évolution de la maladie, l'évolution de l'état de la santé, etc. Donc ça, c'est très très important à ce stade et qui va permettre également d'observer aussi ce qu'il y a de la population entière par rapport à cette maladie, est-ce qu'il y a une diffusion de la maladie, est-ce qu'il faut l'observer, est-ce qu'il faut la contrôler, est-ce qu'il faut aussi s'assurer que cette maladie n'existe pas chez tant de personnes ou est-ce qu'elle est diffuse chez une catégorie donnée, d'où elle vient, etc. Rapidement, comme le dit Michel Foucault, l'hôpital sera une machine à traiter des malades, mais aussi également une façon aussi de jeter un regard sur la population, sur l'état de la santé de la population.

Ce ne sont pas uniquement les malades qu'on accueille, mais surtout de façon générale, quelle est la santé de la population, quels sont les malades, est-ce qu'ils sont nombreux, comment on peut les repérer, etc. Du coup, c'est une fonction, comme il le dit, non seulement l'individu mais aussi la population sont devenus des objets de savoir médical, chose qui va constituer une révolution par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, à côté de l'évolution de l'institution hospitalière et parallèlement à l'évolution de cette institution, les historiens se sont intéressés aussi à l'évolution du regard.

L'évolution du regard, on verra ensemble l'importance du regard sur la maladie. Premièrement, on peut distinguer le regard événement. C'est la période de l'émancipation des représentations religieuses et magiques.

Et c'est le regard qui se base sur ce qui est vu, sur les symptômes de la maladie, sur le regard qu'on porte sur le patient. Et donc, ça c'est un nouveau regard qui s'est imposé, qui s'est longtemps imposé et qui a constitué lui-même une rupture par rapport à un regard, une considération métaphysique qui portait moins l'attention sur le corps, sur le malade et sur les symptômes de la maladie. Voilà, donc ça, ça constitue déjà une rupture, mais ce regard va évoluer vers un regard surtout au XVI^e siècle, avec le développement de l'anatomie, avec l'exploration de ce corps.

On ne se basait plus uniquement sur les signes extérieurs, sur les symptômes extérieurs, mais sur une connaissance du corps de développement, avec le développement de la dissection, avec le développement de la connaissance de la biologie et de la connaissance du corps humain. C'est un nouveau regard qui a en quelque sorte participé à l'invention du corps. C'est un nouveau corps qu'on ne connaissait pas avant, mais c'est un corps qui est créé justement par ce travail exploratoire qui va définir en quelque sorte les différentes composantes du corps avec les différents organes, la définition des fonctions des différents organes.

Et puis, le troisième regard qui va constituer aussi une évolution par rapport à ce second regard, c'est ce qu'on appelle le regard anatomo-clinique. Ce regard résulte justement de la synthèse entre la connaissance anatomique ou l'anatomie pathologique et la clinique qui vont constituer tous les deux justement, et leur fusion, une avancée très importante dans la médecine, c'est-à-dire lier un petit peu la fonctionnalité des fonctions et puis la connaissance anatomique avec la maladie, l'évolution de la maladie. Et ce regard anatomo-clinique va constituer le premier pilier de la médecine, le deuxième étant l'expérimentation, la médecine expérimentale.

On vient de le voir, le regard médical a évolué dans le temps, et surtout au XVII^e, XVIII^e, XIX^e siècle va connaître des évolutions extrêmement importantes qui sont liées à la connaissance du corps, à la connaissance aussi de la maladie. Et donc on est passé d'un regard tout à fait au début magique vers un regard qui se base sur la définition et la connaissance de la maladie, c'est toute l'étape du regard qui se base sur les symptômes extérieurs vers une connaissance de l'anatomie et donc l'exploration du corps connaissance scientifique des organes, etc. vers une connaissance, cette fois-ci, anatomie pathologique et clinique.

Donc ça c'est un élément nouveau qui va impacter d'abord les critères sur lesquels vont être définis et vont être acceptés aussi les malades. Donc ce sont des critères médicaux mais qui découlent de l'auscultation, de l'anatomie pathologique, de la palpation, de la préférence de la clinique, etc. Contrairement à ce qui se faisait auparavant où il y avait d'autres motifs qui ne relevaient pas de ces aspects-là.

Donc ça ce sont des éléments extrêmement importants qui vont instaurer la médecine et surtout on le verra la biomédecine comme un champ spécifique, avec des règles spécifiques avec vraiment une connaissance très développée, très poussée du corps, de la maladie, de la santé, et qui va imposer ses règles justement. Et ce n'est qu'après la 2ème guerre mondiale, surtout en raison du grand nombre de maladies mentales, de malades mentaux, etc. que s'est imposée la question qu'est-ce que la maladie, quoi la maladie.

Ce sont justement les premières questions sur justement qu'est-ce qu'un asile, qu'est-ce qu'un hôpital, comment doit fonctionner un hôpital, comment il doit être géré, comment mettre en place sa logistique devrait-il être géré par des médecins ou par des spécialistes en logistique. Et puis tout ça s'est développé aussi parallèlement au développement des théories qui ont essayé de comprendre les nouveaux modes d'organisation comment s'organiser. Aussi bien au niveau des entreprises, au niveau des administrations mais les hôpitaux aussi n'échappaient pas aux premières discussions sur qu'est-ce qu'un hôpital, comment il doit être géré, quelles sont ses sources de financement, quels sont les différents postes qu'il doit remplir, quelles sont les différentes fonctions, y compris la fonction administrative financière comptable, etc.

Et puis différentes fonctions techniques. Donc on est face à des questions extrêmement importantes qui se sont posées surtout au XXe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle qui vont dans une essence, surtout aux hôpitaux tels qu'on les connaît actuellement. Donc ça c'est extrêmement important.

Alors cette évolution, elle est rapide et beaucoup de travaux de sociologie et de la santé ont été très précoces en questionnant cette institution et en poser les premiers jalons de la sociologie et de la santé tels qu'on la connaît actuellement en renouvelant le débat sur le pouvoir au sein de cette institution sur le rôle des uns et des autres, sur le type d'organisation sur la fonction elle-même de l'hôpital, y compris on le verra quand on va traiter de cet aspect, quelle est la fonction du médecin, quelle est la fonction du malade, etc. Est-ce qu'il y a des médiateurs, etc. Donc ça c'est très important de noter cet aspect-là parce que les évolutions actuelles trouvent leur raison dans cette période-là de création et d'évolution de l'institution hospitalière.

Alors ces évolutions nous amènent vers de nouveaux regards maintenant les spécialistes parlent d'un nouveau regard clinique, interprétatif le corps on le voit à travers de l'imagerie moderne, les scanners, les IRM, etc. Et puis parfois à travers l'image en 3D qui permet de voir directement l'organe et voir un petit peu les lésions on reconstitue un petit peu l'organe humain. Voilà un nouveau regard qui s'est développé grâce aux moyens technologiques modernes.

Mais le regard médical aussi comme le disent certains auteurs maintenant trouve sa justification dans l'interprétation de l'image qu'on a du corps. Pas dans l'observation du corps directement mais des images qu'on obtient, etc. Donc en gros on est dans un regard interprétatif qui est différent des autres regards qui ont été développés jusque-là.

Alors une des questions que posent les spécialistes des médecins, des sociologues des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, quel sera le regard prochain ? Donc ça il faut s'attendre à ce que peut-être on va évoluer de ce regard interprétatif vers un nouveau regard. Vu le développement rapide de la science des technologies, des moyens modernes, il se peut que ce regard que la médecine se fera autrement dans les décennies qui viennent. Un des regards, une des questions que posent les sociologues c'est d'abord quelles sont les fonctions sociales de l'institution, quelles sont les relations entre les malades et les thérapeutes aussi, mais quelle est la place de l'éthique aussi, tous les débats sur l'éthique du métier, quel corps veut traiter les médecins quelle est la relation au corps.

Donc ce sont des questions aussi qui posent beaucoup d'interrogations à des médecins et à des spécialistes qui sont débattus à tous les niveaux.